



血管活性肠肽瘤

(弗纳-莫里森综合征)

作者: [B. Mark Evers](#), MD, Markey Cancer Center, University of Kentucky

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 5月 2024

血管活性肠肽瘤是一种罕见的**胰腺**神经内分泌肿瘤，可生成血管活性肠肽，这种激素可引起重度水样腹泻。

- 这类肿瘤原发于胰腺中产生血管活性肠肽的细胞。
- 主要症状是水样腹泻。
- 诊断方法包括血液检查和影像学检查。
- 治疗方法是补充液体和电解质以及手术。

血管活性肠肽瘤是一类**胰腺神经内分泌肿瘤**。

超过一半的这类肿瘤是癌性（恶性）的。在大约 6% 的患者中，血管活性肠肽瘤作为**多发性内分泌肿瘤**这种疾病的一部分出现。

血管活性肠肽瘤的症状

血管活性肠肽瘤的主要症状是长时间大量水样腹泻。主要症状是经久不愈的大量水样腹泻，患者一天可产生1 000~3 000毫升大便，会引起脱水。50%的患者腹泻是持续的，且在间歇期，腹泻严重程度随时间有所变化。

腹泻会使正常情况下体内存在的盐大量流失，因此患者常会出现血钾水平低（**低钾血症**）和血液内酸过量（**酸中毒**）。这些变化会引起昏睡、肌无力、恶心、呕吐以及痉挛性腹痛。有些人会出现脸红。

血管活性肠肽瘤的诊断

- 血液化验
- 影像学检查

医生根据患者的腹泻症状和血液中血管活性肠肽 (VIP) 水平升高来诊断血管活性肠肽瘤。

具有高水平 VIP 的患者应接受影像学检查，以检测血管活性肠肽瘤的位置。这些检查包括内窥镜[超声](#)、[正电子发射断层扫描](#) (PET) 和奥曲肽闪烁扫描或动脉造影（将不透射线的染液注入动脉后进行的 X 线检查）。

血管活性肠肽瘤的治疗

- 补充液体和电解质
- 奥曲肽或兰瑞肽
- 手术切除

首先，必须通过静脉补充液体和电解质（血液中的矿物质，如钾和钠）。必须补充碳酸氢盐，以弥补其在大便中的流失量并预防酸中毒。尽管补液，因为水和电解质持续丢失而导致脱水，医师会发现难以持续性的去补充水和电解质。

药物奥曲肽或兰瑞肽通常可控制腹泻，但有时需大剂量。

手术切除肿瘤病灶可使约50%患者治愈。手术可暂时缓解已转移的肿瘤患者，化疗无效。

化疗可减轻腹泻并缩小肿瘤，但不能治愈该病。